Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Três Lagoas
Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos

Autos 0800174-39.2019.8.12.0021
Parte Autora: Fátima Ferreira dos Santos Brito
Parte Requerida: Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Selvíria

Vistos, etc.

Fátima Ferreira dos Santos Brito, qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Selvíria, também qualificados nos autos, alegando, em suma, que foi diagnosticada como portadora de Mieloma Múltiplo (CID 90); relata que foi submetida à quimioterapia, contudo, após 10 meses de tratamento, não houve melhora em seu quadro; afirma que em razão do quadro clínico, o médico que a acompanha suspendeu o tratamento quimioterápico e prescreveu o uso contínuo específico do medicamento Bortezomibe, para controle da doença; efetuou o pedido de disponibilização do fármaco na rede pública de saúde, mas obteve negativa, sob o argumento de que a medicação não integra a lista do SUS; assevera que não possui condições financeiras para arcar com os custos provenientes da compra do fármaco. Atribuiu valor à causa, juntou documentos e pediu a gratuidade de justiça.

Pelo despacho de fl. 26, foi determinada a remessa do feito ao NAT, que se manifestou desfavorável quanto ao fornecimento do fármaco, conforme parecer juntado às fls. 29/41.

O Estado de Mato Grosso do Sul manifestou-se, às fls. 51/52, pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Emenda à inicial às fl. 57, substituindo Município de Três Lagoas pelo Município de Selvíria, já que a Autora é residente nesta urbe.

Após, o Município de Selvíria manifestou-se, às fls. 60/61, alegando que não há possibilidade de fornecimento do medicamento via SUS.

Pela decisão de fls. 62/69 foi deferida a tutela de urgência para obrigar os Requeridos a disponibilizarem o medicamento Bortezomibe 3,5mg.

O Município de Selvíria contestou às fls. 85/97, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que só recebe verbas para aquisição de medicamentos que constam do RENAME; que deve ser provada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.

a imprescindibilidade e eficácia dos fármacos que estão fora do RENAME; que não há ordem legal para o Município arcar com medicamento que não é sua competência fornecê-lo; que sua condenação implicaria na desobediência do princípio do limite do possível; que não se pode aplicar multa diária para obrigá-lo a cumprir a obrigação. Requer a improcedência.

Às fls. 104/106, o Estado juntou acordo administrativo pactuado com o Município de Selvíria em que cada um assume a obrigação de disponibilizar metade do tratamento à paciente.

Citado, o Estado de Mato Grosso do Sul contestou às fls. 110/120, requerendo a observância do julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ, que impôs o preenchimento de requisitos cumulativos para o paciente obter a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS; que não há provas da incapacidade financeira da Requerente, tampouco da imprescindibilidade do medicamento pleiteado e da ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS; que medicamentos para tratamento de câncer são disponibilizados por estabelecimentos de saúde credenciados; que o CACON ou UNACON são unidades de saúde especializadas no tratamento de neoplasia maligna; que há remédios similares ao pretendido com comprovada e equiparada eficiência; que não pode ser acolhido o pedido de sequestro de verbas públicas. Pugnou pela improcedência.

Impugnação à contestação às fls.123/133.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das constantes dos autos.

A Autora sofre de Mieloma Múltiplo (CID 90.0) e requer a disponibilização de 32 ampolas do medicamento Bortezomibe 3,5mg, cujo preço unitário é R$ 2.680,79, afirmando não ter condições econômicas para arcar com o custo do tratamento prescrito por médico especialista em hematologia.

Em suma, o Estado de Mato Grosso do Sul afirma que a Requerente não preencheu os requisitos exigidos pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.

enquanto o Município de Selvíria defende sua ilegitimidade passiva para arcar com o tratamento pleiteado na inicial.

Passa-se ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Selvíria.

Não lhe assiste razão.

Todos entes públicos estão arrolados no texto constitucional como legitimados a garantir e efetivar o direito fundamental à saúde. Com efeito, não há norma na Constituição Federal de 1988 que delimite o âmbito de atuação dos Municípios a tratamentos de baixo custo ou de pouca complexidade, por exemplo, ou que o Estado fique circunscrito a determinado campo de atuação.

De fato, o artigo 23, inc. II, da Constituição Federal define a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para cuidar da saúde e assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Veja-se:

> Art. 23. É competência comum da União, dos Estado, do Distrito Federal e dos Municípios:
> (...)
> II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Somado a isso, a Constituição Federal, em seu artigo 196 prevê que:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O termo "Estado" previsto na norma acima deve ser entendido em sua acepção ampla, de modo a englobar todos os entes federativos, ou seja, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios.

Os artigos 2º e 4º, da Lei n.º 8.080/90, que disciplina as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estabelecem:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.

> Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
> (...)
> Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). (destaquei)

Dispõe o § 1º do artigo 198 da Constituição Federal:

> O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Logo, percebe-se que todos os entes possuem legitimidade para figurarem no polo passivo das ações em que seja pleiteado providências relacionadas ao direito fundamental à saúde, de modo que deve ser rejeitado o pedido de exclusão do Município de Selvíria no polo passivo da lide.

A propósito, é firme a Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul nesse sentido:

> E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE CIRURGIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR REJEITADA - REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA - VEROSSIMILHANÇA E COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO IMEDIATO ATENDIMENTO - TRATAMENTO A SER ARCADO PELO RECORRENTE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - NÃO PROVIDO. O Sistema Único de Saúde - SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos federais, estaduais e municipais, a teor do que dispõe o art. 4º, caput, da Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Logo, independentemente do convênio celebrado, a responsabilidade do Município de Naviraí e do Estado de Mato Grosso do Sul na prestação dos serviços de saúde, é concorrente com a União. Deste modo, a recusa do Município de figurar no pólo passivo desta ação, sob a alegação da política de descentralização, onde cada qual procura eximir-se de sua responsabilidade, não prospera. (...)
> *(TJMS - 0802623-53.2013.8.12.0029 – Apelação - 2ª Câmara Cível - Des. Marcos José de Brito Rodrigues – j. em 16/12/2014)*
>
> E M E N T A – AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO – RESPEITO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA RESPECTIVA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA – MEDICAMENTO – MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA CONFIRMADA – PRELIMINARES –

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.

> CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADAS – MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...) Existe solidariedade na assistência à saúde entre a União, o Estado e o Município, podendo a ação ser ajuizada em face de todos, de alguns ou de apenas um, por essa razão, não há falar em ilegitimidade do Estado e do Município para figurarem no pólo passivo da ação. A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados tratamento adequado e eficaz, capaz de ofertar a quem necessite maior dignidade e menor sofrimento.
> *(TJMS - Agravo Regimental -Nº 080170-42.2013.8.12.024/500 - Aparecida do Taboado - 4ª Câmara Cível – Rel. Des. Claudionor Miguel Abs Duarte – j. em 29 de julho de 2014)* (destaquei)
>
> E M E N T A–AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONCESSÃO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DEVER DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são partes legítimas para figurar no polo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos, imprescindíveis à saúde de pesoa carente, não existindo nenhuma hierarquia entre estes na área da saúde, razão pela qual não pode o Estado esquivar-se de seu dever.
> *(TJMS - Agravo de Instrumento -Nº 141043-51.2014.8.12.00 – Naviraí - 3ª Câmara Cível – Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho – j. em 16 de dezembro de 2014)* (destaquei)

Portanto, há solidariedade entre os Municípios, Estados, União e Distrito Federal no que se refere ao dever de fornecer a todos o tratamento de saúde necessário para manutenção da vida com dignidade, por meio do Sistema Único de Saúde, de modo que cabe a qualquer deles isoladamente ou em litisconsórcio, a critério da parte autora, figurar no polo passivo.

Analisada e rechaçada a preliminar, passa-se a examinar o mérito. Assim, do cotejo das alegações trazidas pelas partes, é possível concluir que o pedido inicial merece procedência, senão vejamos.

Com efeito, o direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais constitucionalmente assegurados e efetivadores da dignidade humana. Trata-se de um direito público subjetivo, uma prerrogativa jurídica indisponível garantida à generalidade de pessoas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.

O fundamento constitucional da garantia do direito à saúde encontra-se previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que traz arrolados os chamados direitos sociais, quais sejam:

> São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Assim, o artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral à coletividade no tocante à saúde, entendida como um direito de todos:

> A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.

Conforme assentado por Hewerston Humenhuk :

> A saúde também é uma construção através de procedimentos. (...) A definição de saúde está vinculada diretamente a sua promoção e qualidade de vida. (...) O conceito de saúde é, também, uma questão de o cidadão ter direito a uma vida saudável, levando a construção de uma qualidade de vida, que deve objetivar a democracia, igualdade, respeito ecológico e o desenvolvimento tecnológico, tudo isso procurando livrar o homem de seus males e proporcionando-lhe benefícios.
> *(HUMENHUK, Hewerstton. O direito à saúde no Brasil e a teoria dos direitos fundamentais, 2010)*

Dessa forma, o acesso adequado e eficiente à saúde é bem jurídico constitucionalmente protegido, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público atuante, incumbindo-lhe a formulação e implementação de políticas sociais e econômicas aptas a garantir à coletividade, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar, objetivando a concretização do direito.

No caso em estudo, cristalino o direito da Autora em receber o medicamento pleiteado na inicial, mesmo porque sua qualidade de vida resta prejudicada e o problema de saúde só piorou, notadamente pela refratariedade ao tratamento quimioterápico disponibilizado pelo SUS, mediante Ciclofosfamina + Talidomina + Dexametasona, que não impediram a progressão da moléstia (fl. 13).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.

Modernamente, conforme argumenta o Estado de Mato Grosso do Sul, se apresenta para os casos de fornecimento de medicamentos o precedente de observância obrigatória REsp 1.657.156/RJ do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

> ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
> 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.
> 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.
> 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.
> 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
> *(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)* (destaquei)

Posteriormente, o Colegiado daquela Corte acolheu Embargos de Declaração do Estado do Rio de Janeiro e modificou um trecho do acórdão do recurso repetitivo, trocando a expressão "existência de registro na ANVISA" para

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.

"existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

O Relator do recurso, Min. Benedito Gonçalves, explicou que o esclarecimento em Embargos de Declaração se fazia necessário para evitar que o sistema público seja obrigado a fornecer medicamentos que, devidamente registrados, tenham sido indicados para utilizações *off label* (fora da bula) que não sejam reconhecidas pela ANVISA nem mesmo em caráter excepcional, concluindo-se, ainda, que o *"(...) uso dentro das especificações aprovadas pela agência reguladora é medida que visa proteger o usuário do sistema de saúde, pois estes medicamentos foram submetidos a estudos clínicos que comprovam a sua qualidade, a sua efetividade e a sua segurança" .*

Ao realizarmos o cotejo do presente caso com o precedente de observância obrigatória, conforme impõe o artigo 927, inc. III, do CPC, temos que a *"(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito"* restou evidenciada pelo patrocínio por meio da Defensoria Pública, informação de busca de benefício previdenciário junto ao INSS (fl. 15) e pelo valor final do tratamento, com valor aproximado de R$ 70.000,00.

A *"(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência"* foi comprovada pelo NAT, pois informou às fl. 38 que o Bortezomibe está registrado na ANVISA e esclareceu que "(...) *é utilizado isoladamente para tratar doentes com mieloma múltiplo progressivo, um câncer das células plasmáticas na medula óssea. (...)"* – fl. 38, último parágrafo.

Restando apenas a análise da *"(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS"*, nesse ponto, pela documentação acostada, nota-se que o relatório médico de fl. 13 emitido por médico especialista que acompanha o quadro de saúde da Requerente justificou a prescrição do Bortezomibe pela ausência de reação da paciente ao tratamento quimioterápico que foi submetida anteriormente, demonstrando a ineficácia do procedimento disponibilizado pelo SUS que foi sugerido pelo NAT (fl. 40).

Assim, a despeito de o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT ter se manifestado desfavorável ao atendimento do pedido (fls. 29/41), informando que o medicamento requerido não se encontra padronizado na

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), verifica-se que foi prescrito por médico especialista em hematologia, Dr. Márcio Rodrigo Domingos (fl. 13), que, de maneira detalhada, atestou a imprescindibilidade do Bortezomibe, como também expôs que o tratamento mediante quimioterapia já foi utilizado e não reverteu o quadro de progressão da doença, justificando a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e sugerido pelo NAT às fl. 40.

Assim, em que pese o parecer do NAT tenha sido desfavorável, entendo que, no presente caso, a necessidade do medicamento restou provado para o tratamento da Requerente.

Não há dúvidas, portanto, que a Autora necessita fazer uso do Bortezomibe, ademais, o que se observa no caso em espeque é uma notória desproporcionalidade entre os bens jurídicos colocados em exame, vale dizer, entre tutelar, de imediato, a vida e saúde da Autora e impedir um eventual e pouco provável prejuízo do Poder Público.

Com efeito, sopesando o interesse econômico e social, além das outras tantas obrigações e direitos a serem garantidos à população, e o direito subjetivo inalienável do direito à vida e saúde, deve-se privilegiar o respeito inafastável à vida e à saúde humana da paciente, causando indignação que o pedido não tenha sido deferido mediante simples requerimento administrativo, que precisou de uma ação judicial para valer-se do direito.

Por fim, salienta-se que os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos impõem ao Poder Público a obrigação de fornecer, prontamente, os meios necessários ao tratamento ao necessitado, sobretudo, em casos como o relatado nos autos.

Além disso, não há que se falar em aplicação da teoria da reserva do possível, vez que o fornecimento de atendimento e tratamento adequados à população necessitada, não tem o condão de lesar os cofres públicos. Outrossim, possível que o Estado proteja e efetive os interesses de pessoas desprovidas de satisfatória situação econômico-financeira, que se encontrem em situação de dependência social.

Não é ignorado que a concretização de políticas públicas necessita de destacamento de orçamento específico, de maneira que ficando evidenciada a incapacidade econômico-financeira do Poder Público, torna-se impossível a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.

exigência do cumprimento desses deveres. Contudo, não pode o Estado se isentar de suas responsabilidades constitucionais com fundamento nesse argumento, principalmente, quando se está diante de interesses vitais, dando ensejo à atuação do Poder Judiciário.

A reserva do possível não tem o condão de prevalecer sobre os núcleos essenciais da Carta Constitucional, como é a hipótese do mínimo existencial, entendido como o complexo de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida digna.

Nesse cenário, evidente que o respeito à vida e à saúde deve sobrepor-se ao interesse financeiro do Estado, não servindo eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias como pretexto para negar tais direitos, que integram o patrimônio mínimo do ser humano. Portanto, nessas situações de preservação dos direitos à vida e à saúde, o Supremo Tribunal Federal não adota a teoria da reserva do possível, por considerar que sua proteção não pode ser postergada. A Suprema Corte deixa claro que:

> O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode convertê-la em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...)
> *(STF, RTJ 175/1212-1213, Min. Relator: Celso de Mello, DJ 02/12/2014)*

Por fim, não se afasta a possibilidade do bloqueio de verbas públicas caso descumpridas as decisões que determinam o fornecimento de medicamentos pelo ente público.

Por meio do bloqueio de valores dos Requeridos busca-se assegurar o cumprimento da obrigação imposta, mostrando-se compatível com a manifesta relevância dos direitos fundamentais envolvidos no caso, que devem ser resguardados prioritariamente, sendo certo que só virá onerar os cofres públicos se houver recusa do cumprimento. Tal orientação, inclusive, foi sedimentada por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.474.665/RS - Tema 98 do STJ -, sob o rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C, do CPC/73).

Esclarece-se que há possibilidade do bloqueio de verbas públicas,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.

mas apenas condicionando sua incidência a situações excepcionais ou após constatada a inércia dos Requeridos quanto ao cumprimento da obrigação imposta.

Dessa maneira, a procedência do pedido inaugural é medida que se impõe.

Isso posto, confirmando os efeitos da tutela antecipada, julgo procedente a presente demanda, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Selvíria a fornecerem à Autora o medicamento Bortezomibe 3,5mg/fcc, condicionado à apresentação de receituário médico atualizado e periódico para ser comprovada a continuação da necessidade, especialmente da quantidade, e evitando-se o fornecimento por prazo indeterminado.

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com base no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Isentos das custas e havendo confusão patrimonial entre Defensoria Pública e Estado de Mato Grosso do Sul, em atendimento ao princípio da causalidade, condeno o Município de Selvíria ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, em que pese tenha sido atribuído valor à causa com base no custo do tratamento médico pleiteado, entendo que, por se tratar de direito constitucional à saúde, o presente feito possui proveito econômico inestimável, razão pela qual, por apreciação equitativa, e tendo em vista a baixa complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma dos §§ 2º e 8º, ambos do dispositivo já citado. Tais honorários terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data e juros moratórios pelo índice aplicado à caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da sentença (artigo 85, § 16, do CPC).

Nos termos do inciso I do artigo 496 do Código de Processo Civil, determino que, decorrido o prazo de recurso voluntário, sejam os autos encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, observadas as cautelas legais.

Acaso seja interposto recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Três Lagoas
Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos

Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC).

Na sequência, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Três Lagoas, 15 de julho de 2019.

Aline Beatriz de Oliveira Lacerda
Juíza de Direito
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 06/08/2019 às 09:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800174-39.2019.8.12.0021 e código BWSIMHbF.